

CAPÍTULO 8.15

Patología Biliar

PERFIL EUNACOM 1.06.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

# Abdomen Agudo de Origen Vascular

Las 3 Entidades

| TABLA 8.15.1: ENTIDAD VS MECANISMO |                                                        |                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ENTIDAD                            | MECANISMO                                              | CLÍNICA TÍPICA                                       |
| Embolia mesentérica                | Trombo de FA que emboliza arteria mesentérica superior | Dolor súbito intenso <b>sin signos peritoneales</b>  |
| Trombosis venosa mesentérica       | Trombosis de la vena mesentérica                       | Dolor subagudo (días) + signos peritoneales          |
| Colitis isquémica                  | Isquemia del ángulo esplénico del colon                | Dolor en <b>hipocondrio izquierdo</b> + hematoquecia |

1. Embolia Mesentérica

Contexto clásico EUNACOM

- Paciente con **Fibrilación Auricular: Antiarrítmicos|fibrilación auricular** (ritmo irregular)
- O se describe "ritmo irregular con 2 tonos"

Clínica característica

- Dolor abdominal súbito y muy intenso** (8–10/10)
- Disociación clínicoexploratoria:** dolor intensísimo pero sin signos peritoneales al inicio
  - Sin resistencia muscular
  - Sin Blumberg
  - Sin rigidez abdominal
- Náuseas, vómitos, diarrea al inicio (peristalsis aumentada)
- Evolución: hematoquecia → necrosis intestinal → peritonitis tardía

EUNACOM CRITERIOS

La clave diagnóstica es la **disociación**: un dolor que parece brutal pero el abdomen está casi normal al palparlo. Esto = **embolia mesentérica hasta demostrar lo contrario** en paciente con FA.

Diagnóstico

- Angiografía** (arteriografía mesentérica): estándar de referencia
- Puede hacerse de forma no invasiva: **Angio-TAC** o **Angio-RNM** (confirmatorio)

Tratamiento

- Anticoagulación con heparina** (inmediatamente, ante la sola sospecha)
- Estudio con angiografía (confirma)
- Desobstrucción:** embolectomía quirúrgica o trombolisis

2. Trombosis Venosa Mesentérica

Clínica

- Igual que embolia pero **subaguda** (días, no horas)
- Suele presentar **signos peritoneales** desde antes

Diagnóstico

- TAC con contraste** (ve el trombo venoso directamente)

Tratamiento

- Anticoagulación con heparina** (manejo igual a TVP, porque ES una TVP mesentérica)

3. Colitis Isquémica

Clínica

- Dolor en **hipocondrio izquierdo** (zona del ángulo esplénico = zona de irrigación terminal entre AMS y AMI)
- Hematoquecia
- Puede desarrollar signos peritoneales si se necrosa

Diagnóstico

- TAC abdomen:** edema e isquemia en ángulo esplénico del colon

Tratamiento

- Manejo médico (si no hay necrosis ni perforación)
- Cirugía si se necrosa o perfora

Manejo General de las 3 Entidades

Tres medidas comunes:

- Suero fisiológico EV** (hidratación)
- Antibióticos** (ceftriaxona + metronidazol) → por riesgo de necrosis e infección bacteriana
- Cirugía** → solo si hay necrosis o perforación (no se opera si responde al manejo médico)

Comparación Rápida

| TABLA 8.15.2: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS |             |                          |                             |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                                  | EMBOLIA     | TROMBOSIS VENOSA         | COLITIS ISQUÉMICA           |
| Inicio                                           | Súbito      | Subagudo (días)          | Variable                    |
| Signos peritoneales al inicio                    | <b>No</b>   | <b>Sí</b>                | Variables                   |
| Contexto                                         | FA          | TVP, hipercoagulabilidad | Aterosclerosis, pos-cirugía |
| Dolor                                            | Intensísimo | Moderado-intenso         | Localizado (izq.)           |
| Examen diagnóstico                               | Angio-TAC   | TAC con contraste        | TAC                         |

| Tratamiento | Heparina + desobstrucción | Heparina | Soporte, cirugía si necrosis |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 72 años con antecedentes de coleditiasis ingresa por compromiso del estado general, fiebre con calofríos (39 °C), ictericia franca y dolor en hipocondrio derecho (Triada de Charcot). Examen: PA 85/55 mmHg, FC 120 lpm, desorientada en tiempo y espacio (Péntada de Reynolds). Laboratorio: Bilirrubina 8.5 mg/dL, Leucocitos 19.000/mm³."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Colangitis Aguda Severa (Supurada): infección bacteriana de la vía biliar secundaria a coledocolitiasis obstructiva. La Péntada de Reynolds (Triada de Charcot: Dolor + Ictericia + Fiebre, más Shock e hipotensión y Compromiso de conciencia) define emergencia médica extrema. Manejo: Reanimación intensiva con cristaloides + Antibióticos EV de amplio espectro inmediatos (Ceftriaxona + Metronidazol o Piperacilina/Tazobactam) + Descompresión y drenaje urgente de la vía biliar mediante CPRE (o drenaje percutáneo transparietohepático).

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- Cólico biliar = solo dolor; colecistitis = dolor + fiebre; coledocolitiasis = dolor + ictericia; colangitis = dolor + ictericia + fiebre
- Toda colelitiasis se opera (colecistectomía laparoscópica electiva), incluso asintomática
- Colecistitis aguda: ÚNICA indicación de colecistectomía de urgencia; eco muestra barro biliar + pared gruesa
- Coledocolitiasis: eco (1er examen) → colangiografía (confirma) → CPRE (terapéutica)
- CPRE directa si: colangitis, eco ve cálculos en colédoco, o colangiografía positiva
- Colangitis: tríada de Charcot (dolor+fiebre+ictericia); péntada de Reynolds agrega hipotensión y compromiso de conciencia
- Colecistitis crónicas (porcelana/esclerotrófica): riesgo de cáncer → colecistectomía electiva
- Cirugía abierta solo ante sospecha de cáncer de vesícula

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PATOLOGÍA BILIAR)****PREGUNTA 1**

Paciente con dolor en hipocondrio derecho e ictericia. La ecografía muestra vía biliar de 9 mm sin visualizar cálculos en el colédoco. ¿Cuál es el siguiente examen?

- A)** CPRE directa
- B)** Colangiografía
- C)** TAC de abdomen
- D)** Repetir ecografía
- E)** Biopsia hepática

**PREGUNTA 2**

Paciente con dolor intenso en hipocondrio derecho, fiebre de 39°C, ictericia marcada y tendencia a la hipotensión. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta prioritaria?

- A)** Colecistitis aguda; colecistectomía de urgencia
- B)** Colangitis aguda; CPRE urgente + antibióticos
- C)** Coledocolitiasis; colangiografía
- D)** Hepatitis aguda; soporte
- E)** Cáncer de páncreas; TAC

**PREGUNTA 3**

¿Cuál es la ÚNICA indicación de colecistectomía de urgencia?

- A)** Colelitiasis sintomática
- B)** Colecistitis aguda
- C)** Coledocolitiasis
- D)** Vesícula en porcelana
- E)** Colangitis aguda

**RESUMEN: PATOLOGÍA BILIAR**

Clase que diferencia las patologías biliares: colelitiasis (cálculos en vesícula → colecistectomía laparoscópica electiva), colecistitis aguda (dolor >30min + fiebre + Murphy + barro biliar/pared gruesa → colecistectomía de urgencia), coledocolitiasis (dolor + ictericia → eco→colangiografía→CPRE), colangitis aguda (tríada de Charcot: dolor+fiebre+ictericia, o péntada de Reynolds → CPRE urgente + antibióticos). La CPRE se indica ante: colangitis, eco que ve cálculos en colédoco, o colangiografía positiva. Las colecistitis crónicas (vesícula en porcelana y esclerotrófica) se operan electivamente por riesgo de cáncer. Única indicación de cirugía de urgencia: colecistitis aguda.